内科学含诊断学 呼吸系统疾病

核心精讲·肺结核

（性感认识：变态反应和免疫力常同时发生）→ 决定了原发性肺结核还是继发性肺结核更容易出现空洞

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、临床表现

1.**发热最常见**

（1）多为长期低中热，尤其午后**低热** ①

《诊断学》：低热 37.3-38 度、中热 38.1-39 度、高热 39.1-41 度、超高热＞41 度

慢性低热：结核、支原体肺炎、淋巴瘤等肿瘤、风湿疾病、吸收热（肝硬化门静脉血栓形成等）

不发热或低中热　不发热或低中热　eg.急性心梗坏死物的吸收、盆骨骨折/股骨干骨折的血液吸收

看到高热不会优先考虑结核，但也不能排除

（2）结核毒血症状严重时可有高热，如大叶性干酪性肺炎、急性粟粒性肺结核（全肺广泛三均匀粟粒影），此时可用 ttsx 糖皮质激素（原则：早期足量短程+有抗结核药的情况下）短期结核杆菌大量入血

抗炎不抗菌，提高对伤害刺激的耐受　长期副作用大

2.常有咳嗽咳痰：多为干咳少痰，形成空洞→痰量增多，合并其它感染→脓痰

呼吸系统中看到咯血要想到支扩、结核、肺癌

3.常有**咯血**

病理学中：血管瘤和淋巴管瘤都属于脉管瘤（良性肿瘤，浸润性生长）

→这里的血管瘤应是动脉瘤（血液冲击鼓出来一坨）

（1）多为**痰中带血**（少量咯血）：与毛细血管扩张、通透性增高相关

（2）支气管动脉损伤或空洞血管瘤破裂→咯血量多　支气管动脉：支扩（破坏支气管壁）　支气管静脉：二狭（左心衰）　②

（3）咯血后发热可能是：①结核杆菌播散（低中热）；②血块吸收致吸收热（低中热）；③血块阻塞支气管致阻塞性肺炎（低中热）；④合并其它感染（可高热）

同一部位反反复复出现肺炎

4.常有**盗汗**、乏力、**体重减轻**等　结核是消耗性疾病

慢慢破坏

5.可有胸痛（结核病灶累及壁层胸膜）：多不剧烈；可有呼吸困难（大叶性干酪性肺炎、较多胸腔积液等）　结核性腹膜炎：揉面感柔韧感 VS 一般消化性溃疡导致的腹膜炎：板状腹，硬 ③

6.可有**结核性风湿症**：青少年女性多见，多累及四肢**大关节**，受累关节附近的皮肤间歇出现**环形红斑或结节性红斑**

VS 类风湿：累及小关节

结节病也可有结节性红斑、关节炎

7.体征取决于病变性质和范围

①病变范围较小→无任何体征

语音震颤增强：实变、空洞、胸腔积液的上方，可以闻及异常的支气管呼吸音或异常的支气管肺泡呼吸音

②病变范围 ttsx 较大的渗出、坏死→实变体征（浊音或实音、湿啰音、语音震颤↑、异常支气管呼吸音或异常支气管肺泡呼吸音）传导增强

③病变范围较大的纤维条索→患侧胸廓塌陷、纵隔向患侧移位　eg.慢性纤维空洞型肺结核

④较多的胸腔积液→患侧胸廓饱满、纵隔向健侧移位、浊音或实音、呼吸音减弱或消失

⑤支气管结核→局限性哮鸣音　VS支气管哮喘：小气道的痉挛导致广泛哮鸣音 ④

肺癌也可有

可能可能最可能：**长期低热，多盗汗、咯血，上肺特别是肺尖、锁骨区**

上肺病变优先考虑结核 VS 结节病：病变多侵犯上叶

---

① 理顺低热：

低热是结核病的重要特点，即病例分析题中，若提及病人体温为低热，且病变部位为肺上叶，应重点考虑结核病，当然肺结节病也有类似特征。

若题目中未提及患者为低中热（即＜39度），不优先考虑结核病，但不能因高热症状排除结核病，因干酪性肺炎、急性粟粒性肺结核时，患者同样可出现高热症状。

② 理顺咯血：

①.肺结核病的咯血（多为痰中带血，即少量咯血）是因毛细血管扩张、血管壁通透性增加导致的，但结核病同样可因支气管动脉损伤或空洞血管（动脉）瘤破裂，出现大量咯血；

②.支气管扩张症的咯血是因支气管壁结构被破坏，即造成支气管动脉（营养动脉）破坏导致其咯血；

③.左心衰导致其肺静脉淤血，此时压力升高，但肺静脉管壁较厚，弹性较好不易破裂，故其压力传导至支气管静脉，造成支气管静脉的破裂，出现咯血。

③ 理顺知识点：

结核病是干酪性肉芽肿，即慢性炎症的一种，故对胸壁、腹膜的刺激并不严重，且当结核病灶累及壁层胸膜时，因壁层胸膜主要为躯体神经，故结核病的胸痛多不剧烈，可有呼吸困难。

VS 结核性腹膜炎、肿瘤等对腹膜的刺激较轻，此时腹部触诊呈揉面感，而消化性溃疡穿孔导致腹部剧痛，因消化液对腹膜的刺激最强烈，此时腹部触诊呈现板状腹。

④ 理顺知识点：

肺结核病的体征多种多样，需要对应相应的病理变化后，对应的体征理顺记忆。

结核结节压迫局部的气道，使得气道狭窄，气体通过气道狭窄部时产生干啰音，即哮鸣音。因结核是局部病灶，所以支气管结核为局部狭窄，形成局限性哮鸣音。

肺癌同理，肺癌同样为局部的结节病灶，压迫局部气道出现狭窄，同样表现为局限性哮鸣音。

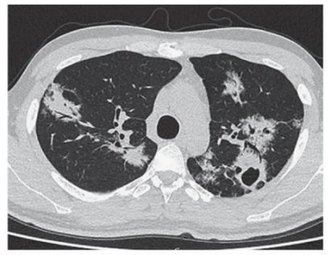
而支气管哮喘为广泛的支气管痉挛，呈现广泛哮鸣音。

二、继发性肺结核

一般内源性复发已形成特异性免疫力

1.概念：机体再次感染结核杆菌，好发成人 感染结核杆菌不等于得结核病
结核杆菌播散到全身各器官后可暂时休眠,机体抵抗力下降使休眠的原发病灶再度活化

2.**常伴空洞**：空洞与结核杆菌细胞壁的蜡质所引起的变态反应相关
（变态反应和免疫力常同时发生）⑤
VS 原发性肺结核:初次感染,无特异性免疫力→很少空洞


图 2-8-5　浸润性肺结核 CT 改变
双上肺渗出影,沿支气管走行,可见空洞形成,内壁光滑。

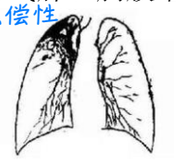
3.继发性肺结核的类型
（1）局灶型肺结核（非活动性）⑥
↓ 沿支气管播散
（2）**浸润型**肺结核（**最常见**的活动性继发性肺结核）：　渗出表现:范围小→大
①境界不清/边缘模糊、密度不均的**云雾状/云絮状影（呈斑点、斑片、实变等）**不均匀
②浸润型肺结核可形成**薄壁空洞**：经支气管播散→干酪性肺炎；空洞经久不愈→慢纤空
→主要是以渗出为主,故边缘模糊不清

（3）**干酪性肺炎（病情危重）**
①严重的干酪性肺炎呈大叶性实变、可有急性高热VS 一般结核:多为长期低中热,尤其是午后低热
②**虫蚀样空洞**（无壁空洞）（VS 肺炎链球菌肺炎绝无空洞）不产生毒素,荚膜致病
⑦

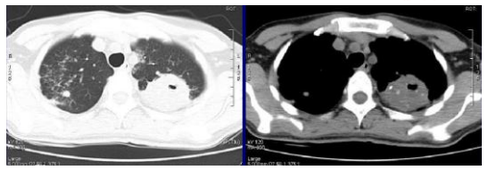



图 2-8-6　干酪性肺炎 CT 改变
右上肺见大片状实变影，可见支气管充气相，局部见钙化灶。

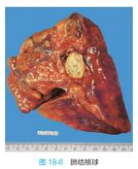
（4）慢性纤维空洞型肺结核
①**厚壁空洞**，肺组织严重破坏、广泛纤维化、肺体积缩小变形，**肺门抬高**、肺纹理呈**垂柳样**，**纵隔向患侧移位**　eg.慢性肺脓肿(病程长)
慢性-纤维化　胶原纤维收缩　病变部位主要好发上叶,胶原纤维→收缩,肺门就被提上去了 ⑧
②并发症：肺气肿、胸膜增厚粘连、气胸(破溃)或脓气胸、大咯血(破坏血管)、喉结核、肠结核(咽下含TB的痰液)、**慢性肺心病**(慢性纤维化肺循环阻力↑)


代偿性



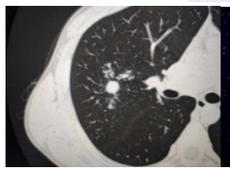


（5）结核球/结核瘤　学姐钙化
①结节内有**钙化**，可分叶和形成空洞，**边界清楚**(纤维包绕)，周围**卫星灶**　肺癌钙化相对少见,但肺癌癌组织也可以出现钙化
卫星灶在肺癌少见,结核多见
②结核球需与周围型肺癌鉴别、且药物不易发挥作用→多**手术**切除（纤维包裹的定时炸弹）


图 18-6　肺结核球








卫星灶

（6）结核性胸膜炎：湿性（结核性胸腔积液，多见），干性

⑤ 理顺变态反应与免疫力关系:
在结核病中,变态反应和免疫力常同时发生,即原发性肺结核指机体初次感染结核杆菌TB,此时机体无特异性免疫力,故其变态反应也少见,即原发性肺结核患者很少有空洞表现(空洞、干酪样坏死与结核杆菌的蜡质成分相关,是变态/超敏反应的类型之一)。

而继发性肺结核患者,机体已有特异性免疫力,故其变态反应也较为多见,即继发性肺结核患者多见空洞、干酪样坏死。

VS 艾滋病合并肺结核患者,因HIV侵犯免疫系统,导致其免疫力降低,故肺结核的变态反应也较为少见,即空洞少见,故此时更倾向于原发性肺结核。

⑥ 理顺知识点:
局灶型肺结核和结核球均为纤维组织包裹形成,但不同的是局灶型肺结核早期病程,此时是机体抵抗力较强,将其病变限制于肺尖处,而结核球多为晚期病程,此时为纤维包裹其干酪样坏死灶。

⑦ 对比:
肺结核的几个空洞鉴别,即:
①.浸润型肺结核为薄壁空洞;②.干酪性肺炎为无壁空洞(即虫蚀样空洞);③.慢性纤维空洞型肺结核为厚壁空洞(分三层,由内到外分别为:干酪样坏死物+结核杆菌、肉芽组织、纤维结缔组织)

⑧ 理顺征象:
慢性纤维空洞型肺结核的核心是纤维化,即因慢性病程出现广泛纤维化,因胶原纤维收缩使得肺体积缩小变形。又因肺结核病的病变好发于肺上叶,收缩的胶原纤维牵拉提升肺门,导致其肺门被拉高,肺纹理相应下垂,呈现垂柳样肺纹理。

又因患侧的胶原纤维收缩,牵拉纵隔,导致纵隔向患侧移动。且肺内大量的胶原纤维压迫肺血管,导致肺动脉高压,进而发展为肺心病。

三、辅助检查

（一）影像学检查

肺结核和肺炎本质都是肺部感染,诊断思路一致:有无肺结核→确诊肺结核病原体

X 线是肺结核的常规首选，可进一步 **CT** 检查

1.抓住 ttsx 继发性肺结核的好发部位：**上叶尖后段、下叶背段和后基底段**（勾肩搭背 hou 基友）

⑨ 注意：合并AIDS的患者免疫力低下→传播途径更类似原发性肺结核(主要经淋巴道和血道播散)→重力原因,下叶血液更丰富→好发于下叶

①艾滋病合并结核好发于**下**叶

②原发性肺结核好发于：**上叶下部、下叶上部近胸膜处**，**肺门淋巴结肿大（原发综合征哑铃状影）**

VS结节病双侧肺门淋巴结肿大

单侧

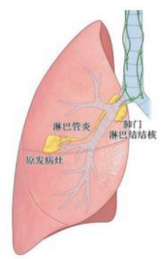
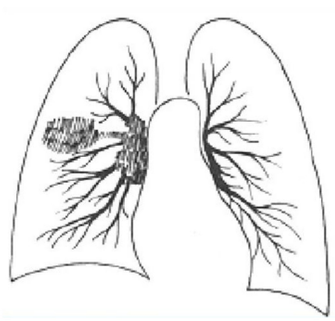
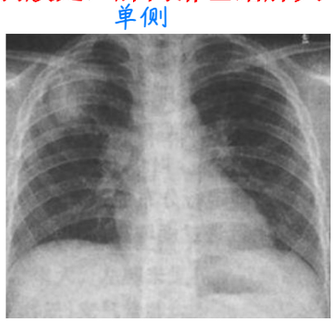


图 18-4　肺结核原发复合征模式图
右侧肺上叶下部胸膜下见黄白色原发病灶，肺门部见肿大的淋巴结，二者之间以淋巴管炎相连。





社区获得性肺炎有很多感染途径就是没有淋巴感染,结核的淋巴管炎只是播散方式,不是从这里感染过来的

2.抓住继发性肺结核的**多形性**改变

浸润性肺结核:薄壁空洞
干酪性肺炎:无壁虫蚀样空洞
慢纤空:厚壁空洞

（1）活动性病变的影像学表现

①渗出：边缘不清、密度不均的云雾状/云絮状影，呈斑点、斑片、实变等 eg.浸润性肺结核

②空洞：无壁、薄壁、厚壁，多无液平

③播散 沿支气管

VS 肺脓肿:有液平

（2）局限、修复的影像学表现

①钙化：边缘清楚、高密度、斑点、结节状（硬结）

②纤维化/条索：边缘清楚、密度增高（硬结）

就算出现钙化、纤维条索,但只要看到渗出、空洞、播散就一定是活动性病变

（二）结核菌素试验（PPD/OT）

1.患者感染结核杆菌的 **4-8 周后**产生致敏 **T 淋巴细胞**，当皮肤再次接触到结核杆菌抗原就可出现皮肤**IV型迟发型**变态反应。PPD 阳性与结核杆菌细胞壁的蛋白质所引起的变态反应相关

2.PPD 检出是否感染结核杆菌，并**非**用于检出是否为结核病 感染结核杆菌不等于结核病

①PPD 是常规检查，但对提示结核病的价值有限（小墓碑选项）受卡介苗、过去感染TB影响

②PPD 阳性对提示 ttsx 婴幼儿、儿童结核病价值较大，特别是**未接种卡介苗的婴幼儿**

⑩ ③PPD 常呈**阴性**或弱阳性的情况：长期用糖皮质激素或免疫抑制剂、癌症、严重细菌感染、粟粒性结核、麻疹、水痘、HIV、结核性脑膜炎、营养不良（苏一爱洗礼、麻豆爱挠痒）

艾滋病

（三）确诊肺结核——痰结核杆菌检查 结核杆菌痰培养慢

1.**痰涂片（确诊首选）**VS 肺炎:痰培养首选(准确率高)

⑪

①痰含菌量＞5000-10000 个**抗酸杆菌**/ml 为阳性

②痰涂片是确定肺结核是否为**传染源**的依据：若**痰涂片阳性（涂阳）**——**开放性**肺结核（**排菌量大**），因此治愈涂阳肺结核是降低肺结核传染最重要的措施

排菌量到达一定量级才会传染

VS 病理学开放性肺结核:慢纤空

⑨ 理顺好发部位:

结核杆菌感染好发于气体多、液体多的部位,上肺的气体多,而下肺虽然血液较多,但血液中的免疫细胞会杀灭结核杆菌,因此普通肺结核好发于肺上叶而并非肺下叶。

当艾滋病合并肺结核时,因HIV攻击免疫系统,导致血液中的免疫细胞较少,结核杆菌可入血,随血液播散至肺下叶,在肺的下叶发生肺结核。即艾滋病合并肺结核时好发于肺下叶。

⑩ 理顺PPD实验:

病理学我们学过,PPD实验是结核病变态/超敏反应的一种,因结核病程中变态反应和免疫反应常同时发生,故PPD实验的基础是机体的免疫力。

当机体免疫力低下时,PPD实验难以呈现阳性,如长期使用糖皮质激素或免疫抑制剂、癌症、严重细菌感染、粟粒性结核、麻疹、水痘、艾滋病等情况下,因机体免疫力低下,其PPD实验常呈阴性或弱阳性。

于病例分析题中,PPD试验的结果需要谨慎分析,常需结合痰液检查结果、病史和临床表现,不可轻易排除诊断。

⑪ 理顺痰涂片:

结核杆菌TB生长缓慢,难以培养。因此,临床上常用痰涂片(首选)进行简单快速诊断。当痰涂片阳性时,说明机体在大量排菌,此时可以诊断肺结核,且此时患者因大量排菌具有传染性,无需再进行痰培养进行诊断。只有痰涂片阴性时,才进行痰培养。

内科学与病理学对于开放性肺结核的定义不同。病理学认为,慢性纤维空洞型肺结核的空洞与外界相通,属于开放性肺结核。

内科学认为痰涂片阳性为开放性肺结核,因痰涂片阳性(涂阳)说明此时患者排菌量较大,传染性较大。

2.**痰培养（确诊金标准）** (12)

痰涂<涂(+):排菌量大有传染性(开放性肺结核)；涂(-):没有传染性

①若**痰培养阳性（菌阳）**——**活动性**肺结核（活性乳酸菌），包括：痰培<菌(+):活动性肺结核；菌(-)

有传染性	痰涂片阳性（**涂阳**）——**开放**性肺结核（**排菌量大**）
无传染性	痰涂片阴性（涂阴）

②**3 次痰涂片+1 次痰培养**均为**阴**性→**菌阴**性肺结核：确诊依靠典型临床表现+典型影像学表现+PPD 强阳性

注意：判断肺结核的活动性　局限、修复的表现

（1）**无活动性（全满足）：无任何症状（无发热等），痰检查不排菌，X 线硬结、钙化、纤维化**

（2）否则为有活动性：①必须抗结核化学治疗，②明确是否有传染性 有活动性不代表有传染性

四、抗结核化学治疗

（一）原则

短程、**早**期、**规**律、**全**程、**适**量、**联**合（多联合 3-4 种药）早恋全是短命鬼 (13)

（二）结核杆菌根据代谢状态分为

A 群	最活跃，干酪液化处特别多，极易耐药	**异烟肼**对 **A** 群最敏感（阿姨）
B 群	处于半静止状态，繁殖速度较慢	**吡嗪酰胺**对 **B** 群最敏感（吡-B）
C 群		**利福平**对 **C** 群最敏感（Selina）
D 群	完全休眠状态、无致病力、无传染性	无任何药物敏感

（三）抗结核药举例

(14)	主要副作用 （多有肝功损害 尤其异烟肼、利福平、吡嗪酰胺）	
异烟肼 H （H-异）	**周围神经炎（手足麻）**→需加 **VitB$_6$** （烟-炎，麻溜-6）	①能渗入全身各组织，易通过血脑屏障，在干酪性病灶、胸水中药物浓度都很高 ②杀细胞内外 TB（**全杀**）
利福霉素类如 利福平 R 和利福喷丁	①若治疗后一过性转氨酶升高：加用保肝药继续用药 肝功能失代偿:黄疸、腹水(黄水) ②ALT 升高 3 倍以上或**黄疸**：**停药**	杀细胞内外 TB（**全杀**）巨噬细胞内外的TB均杀
吡嗪酰胺 Z	**高尿酸**（比内功滋尿）	在细胞**内**杀菌（**半杀**）B群主要存在巨噬细胞内
链霉素 S-锁链	肾毒性、耳毒性 氨基糖苷类抗生素是经典的耳毒性、肾毒性	在细胞外杀菌（**半杀**）
乙胺丁醇 E	**视神经炎**（丁-盯）	**抑菌剂**（乙-E-抑）

吡嗪酰胺、氢氯噻嗪导致高尿酸　呋塞米抑制血管纹的钠钾二氯转运体→降低耳蜗内淋巴电位,降低内淋巴的高钾→感音性耳聋

（四）用药方案

1.活动性肺结核初治 没有链霉素("逊"且肾毒性、耳毒性太大) (15)

①每日用药方案：**2HRZE/4HR（2 个月强化期/4 个月巩固期）** 2 个好人择偶变 4 个好人

②间歇用药方案：$2H_3R_3Z_3E_3/4H_3R_3$ 每周3次(隔日1次)　巩固期时用全杀

注意：结节病和结核病的治疗时间都是至少 6 个月

(12) 串联辅助检查：
确诊有无肺炎:X线→CT;
确诊肺炎病原体:痰培养;
肺结核常规首选:X线,可进一步做CT检查;
确诊肺结核:确诊首选痰涂片,确诊金标准痰培养

(13) 理顺口诀内容：
抗结核治疗需要多种药物,因抗结核药对肝功能影响较大,因此 治疗原则中需注意是短程、适量。
常见干扰选项为足量。

(14) 补充：
异烟肼H、利福平R、吡嗪酰胺R均有潜在的肝毒性作用,用药前和用药过程中应定期监测肝功能,在活动性肺结核合并严重肝炎时,可考虑使用后2SHE/10HE方案。
即不能使用利福平R、吡嗪酰胺Z,但可使用异烟肼H。

(15) 理顺知识点：
氨基糖苷类抗生素具有较为严重的肾毒性、耳毒性,此时副作用较大,大都不使用此类药物治疗。
对于新发初治涂阳病人,吡嗪酰胺Z仅在头两个月使用,因使用两个月的效果与使用四个月和六个月的效果相似,即强化期治疗后不再使用吡嗪酰胺Z

2.复治涂阳肺结核（**先做药敏**）

（1）利福平敏感者：按照初治方案

（2）**RR-TB**（利福平耐药）和 **MDR-TB**（至少耐异烟肼和利福平）的**耐药治疗方案**

①**短程**治疗方案（**首选**）：**9-12 个月**（就要儿子）



②**长程**治疗方案：**≥4** 种抗结核药，**18-20 个月**（180 的 20 个儿子）

所有 **A 组药**（你来北大散心啊）+**≥1 种 B 组药**（法医秦明环视暗算）
当 A 组药只能选用 1-2 种时则选择所有 B 组药
当 A 组和 B 组药不能组成方案时可添加 C 组药

组别	药物（缩写）
A 组：首选药物	左氧氟沙星（Lfx）/莫西沙星（Mfx）
	贝达喹啉（Bdq）
	利奈唑胺（Lzd）
B 组：次选药物	氯法齐明（Cfz）
	环丝氨酸（Cs）
C 组：备选药物	乙胺丁醇（E）
	德拉马尼（Dlm）
	吡嗪酰胺（Z）
	亚胺培南-西司他丁（Ipm-Cln）
	美罗培南（Mpm）
	阿米卡星（Am）
	链霉素（S）
	卷曲霉素（Cm）
	丙硫异烟胺（Pto）
	对氨基水杨酸（PAS）

磺胺是抑菌药,但磺胺和甲氧苄啶复合剂(如复方新诺明)是杀菌剂

《生物化学》：对氨基水杨酸的机制同磺胺：对氨基水杨酸与对氨基苯甲酸结构相似→竞争性抑制二氢蝶酸合酶→四氢叶酸生成障碍→抑制细菌核苷酸代谢（四氢叶酸是一碳单位的载体、一碳单位参与核苷酸代谢）。因此抗结核药中的**抑菌剂**有**乙胺丁醇和对氨基水杨酸**（一对抑菌剂）

一碳单位:只有一个碳原子的有机基团,核苷酸代谢(合成核苷酸)的原料,不能游离存在
可以理解为没有一碳单位核苷酸就不能合成
没有四氢叶酸就没有一碳单位

专题串联·热型

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

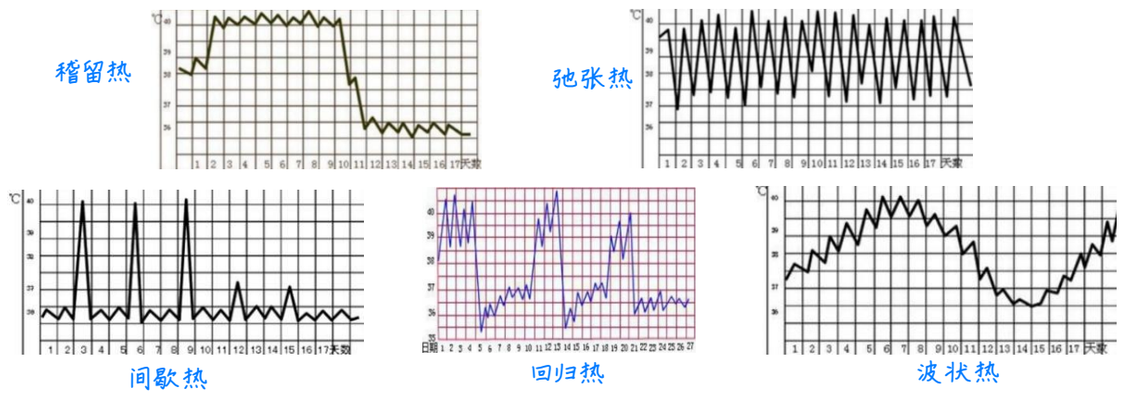
热型	特点	常见疾病
稽留热	体温在高热水平（＞39 度），24 小时内波动范围**不超过 1 度**	**大叶性肺炎**、结核、**伤寒**、斑疹伤寒（鸡大姐上班）
弛张热	体温在高热水平，24 小时内波动范围超过 2 度	败血症、风湿热、重症结核、化脓性炎症（张飞拜师结盟）
间歇热	高热期与无热期各持续数小时后反复交替出现	急性肾盂肾炎、疟疾（生煎疟疾）
回归热	高热期与无热期各持续数天后反复交替出现	霍奇金淋巴瘤（挥霍）
波状热	体温逐渐上升、数天后逐渐下降、后又逐渐上升	布氏杆菌病（跑步波涛汹涌）
不规则热	无一定规律	结核等

16

16 理顺知识点：

间歇热强调高热期持续数小时,回归热强调高热期持续数天,而波状热是体温逐渐上升后逐渐下降。

注意区分各热型的特征。



真题解析·肺结核

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N141-142 B

A.肺炎 默认是大叶性肺炎
B.肺脓肿
C.肺结核
D.支气管扩张症 有误吸的可能

吸入性肺炎和吸入性肺脓肿是一种疾病的不同阶段
吸入性肺脓肿早期可以没有空洞。
大片的边缘不清的浓密模糊浸润影,之后在这个浓密模糊浸润里面再出现带液平的空洞

男性，45 岁。醉酒后出现发热、咳嗽，1 周后咳黏液脓性痰伴胸痛，胸部 CT 示下叶背段大片模糊阴影，密度不均匀，最可能的诊断是

男性，38 岁。受凉后出现发热、咳嗽、痰少 3 天，查体：口周疱疹，右下肺叩浊，可闻及支气管呼吸音，最可能的诊断是 主诉:青壮年受凉后

异常

异常支气管呼吸音:实变、空洞、胸腔积液的积液上方
肺里面听不到支气管呼吸音,最多在上叶听到支气管肺泡呼吸音

2.2015N141-142 B

A.异烟肼
B.利福平
C.吡嗪酰胺
D.乙胺丁醇 阿姨

对结核分枝杆菌 A 菌群作用最强的是
对结核分枝杆菌 B 菌群作用最强的是 B-吡

3.2015N170 X 结核菌素试验阴性可见于

A.结核性脑膜炎
B.儿童结核
C.癌症合并结核
D.营养不良合并结核

感染了TB ┌理论上来说PPD应该(+)
　　└但阴性(假阴性)

4.2016N170 X HIV/AIDS 并发肺结核的特点有

A.容易出现空洞 免疫力下降不容易出现空洞
B.肺下叶病变多见 AIDS时免疫力↓,TB可以存活,顺血流、重力到达下叶
C.结核菌素试验常为阴性 变态反应与免疫反应通常同时发生
D.出现药物不良反应较多

结核性胸腔积液的ADA>45
ADA(腺苷脱氨酶),主要在淋巴细胞里,合并艾滋后,晚期淋巴细胞消失殆尽,所以ADA不升高

合并艾滋的肺结核患者表现趋于原发性肺结核(初次感染结核杆菌,没有特异免疫力),肉芽肿少见
原发性肺结核:原发综合征(原发灶、淋巴管炎、肺门淋巴结的肿大)

答案:1-4BA AC ACD BCD

5. 2018N154 X 下列抗结核药中，属于杀菌药的有
A.利福平
B.异烟肼
C.吡嗪酰胺
D.对氨基水杨酸 一对抑菌药

反复强调必是重点,题干一直在说体温

6. 2020N41 A 男性，23 岁，4 天前东南亚旅游归来后突发寒战、高热，体温达 40.1℃，持续约 2 小时，未经特殊处理自行退热，体温降至 36.2℃，伴大汗，自觉轻度乏力，无其他不适。1 天前再次发热，症状同 4 天前而来院。查体：心肺未见异常，腹软，脾肋下可触及，血化验：WBC 2.2×10^9/L。最可能的诊断是
脾过多破坏RBC导致脾大　疟原虫可以导致WBC↓
巨脾:慢性疟疾、慢性粒细胞白血病/CML
A.伤寒 稽留热 可有脾大 WBC多↓ 玫瑰疹
B.疟疾 生煎疟疾
C.败血症 弛张热 局部原发灶+全身不适 WBC↑↑或三低现象(T/WBC/BP↓)
D.肾综合征出血热 醉酒表现(脸红、眼红)、出血点、蛋白尿、血尿

7. 2023N43 A 女性，40 岁。低热、间断咯血 2 个月，每次 3~4 口，鲜红色。既往体健。查体：T 37.8 度，双肺叩诊清音，呼吸音清，未闻及干湿啰音。肺 CT 示双上肺多发结节，内有空洞。最有助于确诊的检查结果是
A.PPD 试验皮肤可见水疱
B.肺穿刺活检可见肉芽肿病变 VS 结节病:支气管镜见黏膜结节呈铺路石样,支气管镜/穿刺活检为非干酪性肉芽肿
C.痰涂片抗酸染色阳性
D.γ-干扰素释放试验阳性诊断结核的一个检查,主要用于科研里

8. 2024N45 A 男性，56 岁。低热、盗汗伴咳嗽、咳痰 2 月余。既往吸烟 30 年，20 支/日。查体：体型消瘦，浅表淋巴结无肿大，双肺听诊无异常。血 WBC 8.0×10^9/L，N 59%，胸部 X 线片示“左上肺密度不均匀片状影”。最可能的诊断是
A.肺结核
B.肺炎
C.肺脓肿
D.肺癌

思维导图·肺结核

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案:5-8 ABC B C A